# Gestión 2 — Test A/B del título: protocolo pre-registrado

Este protocolo se fija **antes** de recolectar datos, con regla de decisión y predicción del autor declaradas por adelantado. El libro exige compromisos observables; su título no puede decidirse con menos.

## Pregunta y opciones

¿Qué título maximiza que un médico tome el libro, entienda de qué trata y lo considere creíble?

- **Opción A (actual):** *Hechos, inferencias e incertidumbre* — subtítulo: *Metacognición, lenguaje y decisión clínica*.
- **Opción B (propuesta):** *Medicina lúcida* — subtítulo: *Hechos, inferencias e incertidumbre en la decisión clínica*.

## Diseño

- **Muestra:** mínimo 20, ideal 30 médicos y residentes. Mezcla deliberada: ~1/3 residentes, ~1/3 especialistas clínicos, ~1/3 otras especialidades/APS. Excluir: familiares, personas que ya conocen el proyecto (contaminación), no médicos.
- **Material:** las dos portadas maquetadas (`portada_A.png`, `portada_B.png`), **idénticas en todo salvo título y subtítulo** — misma tipografía, color y composición, para que el test mida el título y no el diseño.
- **Aleatorización del orden:** dos versiones del formulario; la versión 1 muestra A primero, la versión 2 muestra B primero. Asignar alternadamente según orden de llegada (1º respondente → versión 1, 2º → versión 2, etc.) o duplicar el formulario en Google Forms y repartir los enlaces alternados.
- **Ciego:** no revelar cuál es el título "actual" ni cuál prefiere el autor. El mensaje de reclutamiento no menciona que hay un título en uso.

## Cuestionario (listo para pegar en Google Forms)

**Intro del formulario:** "Te pido 3 minutos para ayudarme a decidir la portada de un libro dirigido a médicos. No hay respuestas correctas. Tus respuestas son anónimas."

1. *(Mostrar SOLO la primera portada según versión)* **Sin pensarlo más de 10 segundos: ¿de qué crees que trata este libro?** — respuesta corta.
2. *(Mostrar ambas portadas lado a lado)* **Si vieras estos dos libros en un congreso, ¿cuál tomarías primero para hojear?** — opción única: Portada A / Portada B.
3. **¿Cuál comprarías, si compraras uno?** — opción única: A / B / Ninguno.
4. **Evalúa cada título de 1 a 7** *(cuadrícula de escala; una fila por título)*: (a) Me atrae; (b) Entiendo de qué trata; (c) Me parece un libro serio/confiable; (d) Se lo recomendaría a un residente.
5. **¿Alguno de los dos títulos te produce rechazo o desconfianza? ¿Cuál y por qué?** — respuesta corta, opcional.

6. **Tu perfil:** Residente / Especialista clínico / APS o familiar / Otro — y años desde el título: <5 / 5–15 / >15.

## Regla de decisión (pre-especificada, no negociable después de ver datos)

- Si una opción gana la **elección forzada (pregunta 2)** con **≥ 60%** Y **no pierde** en credibilidad (ítem 4c, diferencia de medias < 0,5): **se adopta esa opción**.
- Si la elección forzada queda entre 40% y 60% para ambas: **empate técnico** → decide la editorial cuando exista; mientras tanto se conserva la opción A (statu quo).
- Si una opción gana la elección forzada pero pierde claramente en credibilidad (4c, diferencia ≥ 0,5 a favor de la otra): se revisan las respuestas abiertas (preguntas 1 y 5) antes de decidir, y la síntesis se escribe ANTES de saber cuál título favorecía el autor.
- La pregunta 1 tiene veto: si ≥ 30% de los respondentes no logra inferir que el libro trata de razonamiento/decisión clínica con un título dado, ese título queda descartado aunque gane en atractivo. Denominador pre-especificado: como cada respondente explica sólo la primera portada que ve, la comprensión de cada título se mide únicamente entre quienes recibieron la versión del formulario que lo muestra primero (la mitad de la muestra). El veto sólo se aplica con un mínimo de 10 respuestas válidas por título (20 en total); las respuestas abiertas se codifican como «infiere / no infiere» por una persona que no conoce qué título vio cada respondente, antes de calcular el porcentaje.

## Predicción del autor (completar ANTES de enviar el formulario — ejercicio de calibración del Taller 5 aplicado a uno mismo)

> "Predigo que la opción ___ ganará la elección forzada con ___ % (confianza: ___ %).
> Predigo que la comprensión (pregunta 1) será mejor con la opción ___."

Guardar la predicción con fecha. Al cerrar el test, comparar. Ese pequeño acto es el libro entero en miniatura.

## Mensaje de reclutamiento (WhatsApp / correo)

> Hola, [nombre]. Estoy terminando un libro para médicos y necesito decidir la portada con datos y no con corazonadas. ¿Me regalas 3 minutos anónimos? [ENLACE]. No te digo nada más para no sesgarte — después del cierre te cuento qué salió. ¡Gracias!

## Logística y análisis

1. Crear el formulario en Google Forms con las 6 preguntas (duplicarlo para la versión con orden invertido); subir `portada_A.png` y `portada_B.png` como imágenes en las preguntas.
2. Enviar a 30–40 contactos para lograr ≥ 20 respuestas; cerrar a los 7 días.
3. Análisis en 30 minutos: proporción de la elección forzada (con n); medias por ítem de la pregunta 4; lectura temática de las preguntas 1 y 5 (¿el título comunica "razonamiento clínico" o comunica otra cosa?); aplicar la regla de decisión tal como está escrita.
4. Registrar el resultado y la decisión en este archivo (sección siguiente) — y contrastar con la predicción.

## Resultado (completar al cierre)

| Fecha cierre | n | Elección forzada A/B | Credibilidad A/B | Veto comprensión | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|